

× 「肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解(2012年改訂)」では再治療例や化学療法後経過の悪い例のみ感受性検査を推奨していたが、2020年の米国胸部疾患学会・米国感染症学会らのガイドライン(Treatment of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: An Official ATS/ERS/ESCMID/IDSA Clinical Practice Guideline)では感受性結果に基づいた治療が推奨されている。

①

× 結核とは治療に用いる薬剤が異なる。

× 経過観察可能症例には分類されるが、年齢によらず、空洞を有する病変や血痰を有する場合、喀痰塗抹排菌量が(2+)以上の症例などでは治療が検討される。

なお、2020年の米国胸部疾患学会および米国感染症学会らのガイドラインでは、年齢によらず原則として治療開始が推奨されている。

× 耐性化の懸念があり、原則として単剤投与は行わない。

○ マクロライド系抗菌薬への誘導耐性・変異耐性の有無が異なるため、2020年の米国胸部疾患学会および米国感染症学会らのガイドラインにおいて、マクロライド系抗菌薬の誘導耐性・変異耐性の有無に応じてレジメンを検討することが記載された。

○ マクロライド系抗菌薬の誘導耐性に関連する *erm41* 遺伝子を有しておらず、マクロライドを含んだレジメンが使用可能である。

× レボフロキサシンは保険適応がある。

○

○

○ 750 mg/日までとされている。

× 2021年12月時点では、クロファジミンはハンセン病以外に日本での正式な保険適応は有していない。